

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL)

استخراج حصوات الكلية عن طريق فتحة في الجلد

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure.
(Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
A Percutaneous Nephrolithotomy is a minimally invasive surgical procedure to remove stones from the kidney.

C. Risks of a percutaneous nephrolithotomy (PCNL)

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

هل توجد حاجة لخدمات الترجمة ؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة بنعم ، هل هناك مترجم حاضر ؟ ☐ نعم ☐ لا

ب . الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من : (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق – يشمل ذلك موضع و/أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالتالي :
استخراج حصوات الكلية عن طريق فتحة في الجلد هو إجراء جراحي بسيط لإزالة الحصوات من الكلية.

ج. مخاطر استخراج حصوات الكلية عن طريق فتحة في الجلد

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى يتطلب علاجها المضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايبييردامول (بيرسانتين أو اساسانتين).
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.

- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Bleeding, rarely risk of severe bleeding requiring open exploration of the kidney. If this occurs, the kidney may have to be removed.
- Infection, Rarely Septicaemia (blood poisoning). Antibiotics are usually given to help prevent this.
- Very rarely, injury to the bowel. Further surgery and repair may be required.
- Injury to the pleura (lining of the lung cavity). This may require a tube to be put into the chest to re-inflate the lung.
- During the procedure, a small fragment of stone may fall into the ureter causing a blockage. If this happens, a stent (a drainage tube between the kidney and the bladder) may be inserted.
- The aim of the procedure is to either clear the stone altogether or break up the stone. If breaking up of the stone is done, further surgery may be needed to remove other pieces of the stone from within the kidney.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر ، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.

- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- نزيف. هناك احتمال ضئيل جداً بخطر حدوث نزيف شديد يتطلب جراحة مفتوحة لاستكشاف الكلية. إن حدث ذلك ، فقد يكون من الضروري إزالة الكلية.
- التهابات. احتمال تجرثم (تسمم) الدم. تعطى عادة المضادات الحيوية للمساعدة على تفادي حدوث ذلك.
- من النادر جداً حدوث إصابة للأمعاء . قد تكون هناك حاجة للإصلاح الجراحي.
- إصابة غشاء الجنب (الغشاء البلوري) وهو الغشاء المبطن لتجويف الرئة. قد يتطلب ذلك وضع أنبوب في الصدر لإعادة نفخ الرئتين بالهواء.
- أثناء الإجراء ، قد تسقط أجزاء صغيرة من الحصوة إلى داخل الحالب مسببة انسداداً للحالب. عند حدوث ذلك ، فقد يتم إدخال دعامة (أنبوب تصريف بين الكلية والمثانة البولية).
- إن الهدف من الإجراء هو إما إزالة الحصوة بشكل كامل أو تفتيت هذه الحصوة. إذا تم تفتيت الحصوة ، فقد تكون هناك حاجة لجراحة أخرى لإزالة الأجزاء الأخرى من الحصوة من داخل الكلية.

د . مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الإجراء

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anesthetic. (Doctor to document type of anesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the

هـ . مخاطر عدم الخضوع للإجراء
(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل
المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و . التخدير
قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب
المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

- ز . إقرار المريض
- أقر بأن الطبيب قد شرح لي :
- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقفاً . أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
 - التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
 - الخيارات الإجرائية الطبية \العلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
 - المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
 - عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.

- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ About your Anesthetic
- ☐ Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL)

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date:.....Time:.....

تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.

- قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .
- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ،وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.

- إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .

- قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق المعلومات التالية:

- ☐ نوعية التخدير المقدم لي
- ☐ استخراج حصوات الكلية عن طريق فتحة في الجلد

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي.وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
- أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
- أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وان ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

وبناء على ما تقدم، فإنني أطلب الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ :الوقت:.....

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s: _____

Signature: _____

Relationship to patient: _____

Date: _____ Time: _____

Contact No: _____

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate: _____

Designation: _____

Signature: _____

Date: _____ Time: _____

Witness (es) (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

المرضى فاقد القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب
ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح
أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار :

التوقيع :

صلته بالمريض :

التاريخ : الوقت :

رقم الإتصال :

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب
لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار
المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم
جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب :

طبيعة الإنابة :

التوقيع :

التاريخ : الوقت :

توقيع الشهود :

1) الاسم : _____ التاريخ : _____

التوقيع : _____ الوقت : _____

2) الاسم : _____ التاريخ : _____

التوقيع : _____ الوقت : _____